

Dra. María Fernanda Adjounian

Estrategia de contenido y captación de pacientes para un equipo de cirugía mastológica con trayectoria de más de 20 años.

*"Los serios. Los que llevan más de 20 años.
A quienes otros médicos les refieren sus casos difíciles."*

01 RESUMEN DEL PROYECTO

El objetivo no es "vender cirugías": es construir confianza y autoridad médica para acompañar a pacientes que enfrentan un diagnóstico difícil (nódulos, cáncer de mama) y necesitan seguridad, experiencia y trato humano antes de decidir quién las va a operar.

Educación 50-60%

Autoridad 20%

Historias 10-15%

Miedos 10%

02 POSICIONAMIENTO CENTRAL

EL DIFERENCIADOR

Trayectoria y rigor médico frente a los "médicos influencer" con más marketing que experiencia. No se venden gimmicks: se comunica gravedad, experiencia y respaldo científico.

Público objetivo

Segmento	Estado emocional	Qué busca
Mujer en prevención	Alerta, informándose	Educación, cuándo hacerse chequeos
Hallazgo reciente (nódulo)	Ansiosa, con miedo	Calma, claridad, próximos pasos
Paciente diagnosticada	Aterrada, vulnerable	Confianza en el cirujano, opciones
Familiares / referidores	Buscando por su ser querido	Reputación, resultados, humanidad

03 PILARES DE CONTENIDO

Educación y prevención (motor de alcance)

Autoexamen paso a paso · Mitos del cáncer de mama · Edad ideal para la primera mamografía · Qué significa un nódulo

El equipo como autoridad

Perfil de cada cirujano (años de experiencia, formación, casos) · Por qué eligieron esta especialidad · Detrás de cámara discutiendo casos

Historias de pacientes (con consentimiento firmado)

Testimonios de superación, sin dramatismo ni comparaciones morbosas — el contenido más poderoso y el más delicado

Resolución de miedos concretos

Opciones de reconstrucción · Qué pasa desde el diagnóstico hasta la cirugía · Preguntas en vivo

04 FORMATOS Y CANALES

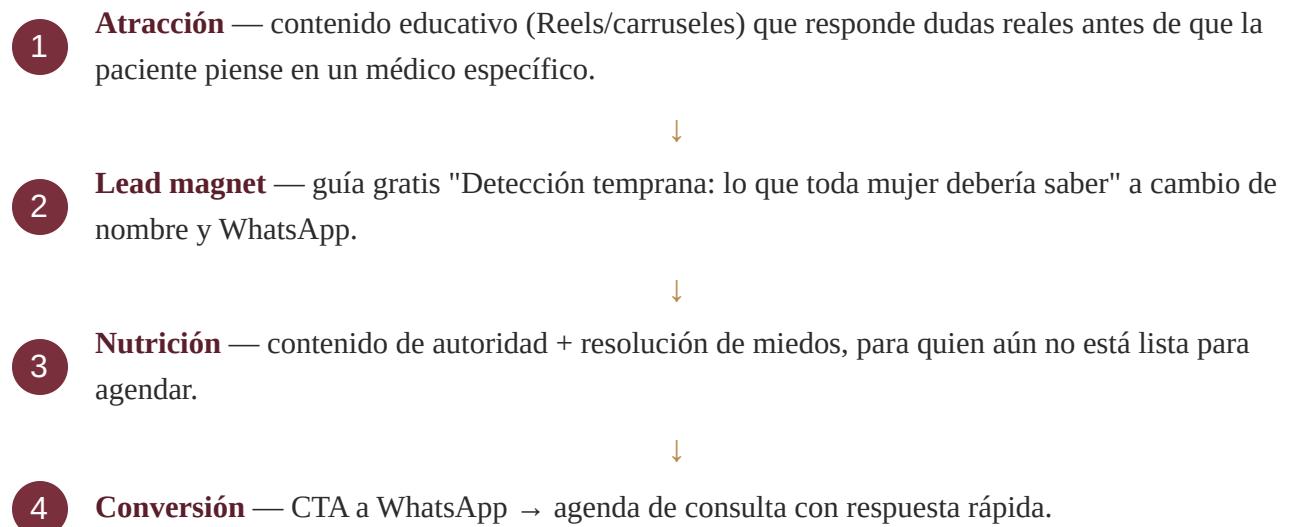
- **Reels / Shorts** — video vertical corto, motor de alcance orgánico.
- **Carruseles** — explicación paso a paso de temas educativos.
- **Lives / Q&A** — momento de cierre de confianza.
- **Stories** — cercanía diaria, encuestas y preguntas.
- **CTA principal: WhatsApp** — canal natural para agendar en el contexto local.

FRECUENCIA SUGERIDA

3–4 publicaciones por semana en feed (mezclando los 4 pilares) + stories diarias — presencia constante sin saturar la producción del equipo médico.

05 EMBUDO DE CONVERSIÓN

El contenido no vale nada si no conduce a algún lado. Este es el recorrido que hacemos con cada paciente potencial, desde que ve un video por primera vez hasta que agenda su consulta.



Métricas clave por etapa

Etapa	Qué medir	Meta orientativa
Atracción	Alcance, impresiones, guardados/compartidos	Crecimiento sostenido mes a mes
Lead magnet	Visitas a la landing → descargas de la guía	15–25% de conversión en la landing
Nutrición	Apertura/respuesta en WhatsApp o email	Contacto activo con 40%+ de los leads
Conversión	Leads que agendan consulta, tiempo de respuesta	Respuesta en menos de 1 hora

POR QUÉ IMPORTA MEDIRLO ASÍ

Una paciente con un hallazgo reciente no siempre agenda en el primer contacto: necesita tiempo para procesar el miedo. Medir cada etapa por separado evita perder de vista a quien todavía está en la fase de "nutrición" y solo necesita un empujón más, no otro anuncio genérico.

Además del plan de contenido en redes, estas líneas capturan pacientes que **ya están buscando activamente** o que llegan por vías distintas a Instagram/Facebook — clave porque muchas pacientes diagnosticadas buscan primero en Google, no en redes sociales.

1 Servicio de "Segunda Opinión"

Posicionar explícitamente un servicio de segunda opinión médica. Es el segmento de mayor intención: pacientes ya diagnosticadas en otro centro que dudan y buscan una voz experta antes de operarse. Encaja perfecto con el posicionamiento de "los serios, los de 20 años de trayectoria".

Cómo empezar: crear una sección "Segunda opinión" en la landing y mencionarla en la biografía de Instagram.

Impacto: alto

2 Google Business Profile + SEO local

Optimizar la ficha de Google (reseñas, fotos, horarios, preguntas frecuentes) y una landing con contenido para búsquedas de alta intención ("cirujano mastólogo + ciudad", "segunda opinión cáncer de mama", "nódulo mamario qué hacer"). La mayoría de las pacientes con diagnóstico confirmado buscan en Google antes que en Instagram.

Cómo empezar: reclamar y completar la ficha de Google con fotos del consultorio y del equipo. **Impacto:** alto

3 Aprovechar Octubre Rosa

El mes de sensibilización del cáncer de mama empieza en pocos días. Es la ventana de mayor atención mediática del año: campaña especial de contenido, alianza con farmacias/empresas/gimnasios para charlas de concientización, y posible jornada de chequeo o tamizaje.

Cómo empezar: armar un mini-calendario de 4 semanas y contactar 2–3 aliados esta semana.

Impacto: alto, ventana corta

4 Red de referidos médicos

Alianzas activas con ginecólogos, radiólogos, oncólogos y médicos de cabecera. Charlas o webinars dirigidos a colegas refuerzan la idea de "a quienes otros médicos refieren sus casos difíciles" y generan un canal de pacientes de alta calidad, no solo de redes.

Cómo empezar: listar 10 colegas para invitar a una charla o enviarles material de referencia.

Impacto: medio-alto, maduración lenta

5 Chatbot de WhatsApp para primer contacto

Responde preguntas frecuentes, explica el proceso y agenda la primera cita sin depender de que alguien conteste manualmente. Reduce fricción justo en el momento de mayor ansiedad de la paciente.

Cómo empezar: definir 5–8 preguntas frecuentes y automatizar la respuesta más el botón de agendar.

Impacto: alto

6 Gestión activa de reputación

Reseñas en Google/Doctoralia y testimonios en video (con consentimiento) como prueba social visible — decisivo cuando la paciente está comparando médicos antes de decidir.

Cómo empezar: pedir reseñas a pacientes satisfechas con un sistema simple de solicitud post-consulta.

Impacto: medio, construcción gradual

7 Telemedicina para preconsulta

Consulta virtual inicial para pacientes de otras ciudades o del exterior, muy relevante dado el contexto de familias venezolanas dispersas que gestionan la salud de un ser querido a distancia.

Cómo empezar: habilitar una preconsulta virtual breve por videollamada.

Impacto: medio, amplía alcance geográfico

8 Newsletter / lista de difusión de WhatsApp

Contenido educativo mensual para mantener "tibia" la relación con quienes descargaron la guía pero aún no agendan, sin depender de pauta paga (más restringida por las políticas de salud de Meta).

Cómo empezar: armar la lista con los leads del lead magnet y enviar un contenido al mes.

Impacto: medio, retención a mediano plazo

CÓMO PRIORIZAR

Fase 1 (primer mes): segunda opinión, Google Business Profile, Octubre Rosa y chatbot de WhatsApp — son las de mayor impacto con menor esfuerzo. Fase 2: red de referidos, reputación, telemedicina y newsletter, una vez el flujo básico esté funcionando.

08 REGLAS ÉTICAS Y DE CUMPLIMIENTO

- No prometer "cura" ni garantizar resultados — protege al equipo médico y cumple las políticas de anuncios de salud de Meta.
- Meta restringe fuertemente el contenido oncológico pagado; se revisa cada pieza antes de pautar.
- Consentimiento por escrito para cualquier imagen o testimonio de paciente.
- Dignidad ante todo: son personas en su momento más vulnerable.

09 PRÓXIMOS PASOS

● **Semana 1 — Definición**

Tono de voz e identidad visual del equipo; validar el enfoque de "segunda opinión" con la Dra. Adjounian.

● **Semana 1-2 — Producción base**

Diseño del lead magnet (guía PDF) y calendario de contenido de las primeras 2–4 semanas, alineado con Octubre Rosa.

● **Semana 2-3 — Infraestructura**

Configurar flujo de WhatsApp / chatbot, optimizar Google Business Profile y activar la sección de segunda opinión.

● **Semana 3-4 — Lanzamiento**

Publicación del primer ciclo de contenido, activación de alianzas médicas y seguimiento de leads en el dashboard.

COMPONENTES TÉCNICOS DE SOPORTE

Landing page con captura de leads · Calendario editorial en datos · Bot de WhatsApp (FastAPI) · Dashboard de métricas de alcance, leads y conversiones.

10 INVERSIÓN Y PAQUETES DE SERVICIO

Precios de referencia en dólares (USD) — moneda en la que se cotiza el trabajo freelance/digital en Venezuela por la inestabilidad del bolívar. Se ajustan según el alcance final que se acuerde.

Componente	Rango (USD)	Frecuencia
Diagnóstico + estrategia inicial	\$150 – \$350	Pago único
Gestión de contenido (redes)	\$250 – \$600	Mensual
Lead magnet + landing de captura	\$150 – \$400	Pago único
Chatbot / flujo de WhatsApp	\$300 – \$900	Pago único
Community management	\$100 – \$250	Mensual
Gestión de pauta paga (Meta/Google)	10–20% del presupuesto, o \$150–\$300 fijo	Mensual
Dashboard de métricas y leads	\$150 – \$400	Pago único

Paquetes sugeridos

Paquete Inicial — Mes 1

Estrategia + lead magnet + landing + calendario de contenido alineado a Octubre Rosa. **\$500 – \$900** (pago único)

Retainer Mensual — Mes 2 en adelante

Producción y publicación de contenido, community management y reporte de métricas. **\$350 – \$700** / mes

Add-ons por fuera del retainer

Chatbot de WhatsApp y gestión de pauta paga, cotizados aparte según el alcance que se decida activar.

RECOMENDACIÓN

Cobrar por paquete de valor, no por hora: en salud, el cliente entiende mejor "esto trae pacientes potenciales" que una tarifa horaria. El mismo posicionamiento de "los serios, los de 20 años" aplica también a la tarifa del equipo de mercadeo.